



## Ministério da Saúde

Urgencia Nº: XX Data Urg.: xx-xx-xxxx xx:xx:xx  
Proc.: XXXX Identificação N. Utente: XXXX  
Nome: XXX  
Data Nasc.: XX/XX/XXXX (XX Anos) Prof XXXXX Sexo: XXX  
Morada: XXXX  
Localidade: XXXXx Telefone: XXXX

### Médico Família

Centro de Saúde: XXXXX  
Médico: XXXXXX

### Outros Dados

Causa : XXXXXX Proveniência: XXXXXx  
Subsistema: XXXXXX  
Observações: XXXX

### Triagem

Data / Hora da Triagem: XXXXX  
Discriminador: xxxxx

Fluxograma : XXXX

Prioridade Clínica

Temperatura: Dor: XX

Glasgow: XXXXX

PEFR: Freq. Resp.: PA: /

Glicémia: Corpos cetónicos: Freq. card.: Ritmo de pulso:

Oxi. per.:

Mobilidade: XXXXXx

Especialidade: XXXXX Grupo: XXXXX Sala: XXXX

Queixa: XXXXX

Justificação Via Verde:

Triador: XXXXXXXX Nº. Mecanográfico: XXXX Ass.: \_

### Observações Médicas

30-Abr-2026 16:42:00 Dr(a). Marta Lemos (HUC-URG\_GASTRENTEROLOGIA)

Mulher, 45a, recorre por dor abdominal predominantemente em FID, progressiva, c/ 3 dias evolução, associada a aumento do trânsito intestinal, 4-5 defeções/dia, líquidas/pastosas, s/ sangue ou muco visível. Nega febre, vômitos, distensão abdominal marcada, rectorragias, melena, sintomas urinários ou queixas ginecológicas. Sem contactos conhecidos c/ gastroenterite, sem viagem recente, sem ingestão alimentar suspeita. Mantém tolerância oral, embora c/ menor apetite. Refere quadro semelhante a episódios prévios de actividade ileal.

AP: doença de Crohn ileocólica dx 2018, habitualmente em remissão clínica; FA paroxística sob anticoagulação; perturbação depressiva major em remissão parcial. Apendicectomia 2015. Anemia ligeira previamente associada a DII. Alergia a sulfamidas - exantema maculopapular.

MH: apixabano 5 mg 12/12h, bisoprolol 2,5 mg id, azatioprina 100 mg id, mesalazina 1,2 g 12/12h, sertralina 100 mg id. Refere adesão habitual, sem suspensão recente de azatioprina/mesalazina. Sem AINEs.

EO: consciente, orientada, colaborante. Estado geral conservado, discretamente desconfortável por dor. Mucosas ligeiramente secas, coradas. TA 124/76 mmHg, FC 82 bpm, FR 16 cpm, SpO2 99% AA, T 36,7°C. Cardíaca rítmica, sem sopros; sem sinais de insuficiência cardíaca. AP: murmúrio vesicular mantido bilateralmente, sem ruídos adventícios. Abdômen plano, depressível, ruídos hidroaéreos presentes, dor à palpação profunda em FID e discretamente peri-umbilical, sem defesa, contractura ou descompressão brusca dolorosa. Sem massas palpáveis, sem organomegalias. Sem dor lombar à punho-percussão. TR não realizado, sem indicação imediata na ausência de exteriorização hemática/queixas anorretais. Sem edemas periféricos; perfusão distal mantida.

Analítica: Hb 11,3 g/dL, Htc 34,8%, VGM 84 fL, leucócitos  $12,6 \times 10^9/L$ , neutrófilos  $9,4 \times 10^9/L$ , plaquetas  $412 \times 10^9/L$ . PCR 48 mg/L, VS 38 mm/h. Ionograma s/ alterações relevantes: Na 138 mmol/L, K 4,1 mmol/L. Ureia 24 mg/dL, creatinina 0,72 mg/dL, TFGe  $>90 \text{ mL/min/1,73m}^2$ . Glicemia 101 mg/dL. AST 19 U/L, ALT 22 U/L, FA 91 U/L, GGT 28 U/L, bilirrubina total 0,4 mg/dL. Lipase 24 U/L. Urina II s/ leucocitúria, nitritos, hematúria ou proteinúria. Calprotectina fecal 1260  $\mu\text{g/g}$ , muito acima do valor basal referido habitualmente  $<150 \mu\text{g/g}$ , compatível c/ actividade inflamatória intestinal significativa.

Ecografia abdomino-pélvica: ansa ileal terminal visualizável em FID c/ espessamento parietal circunferencial até 6-7 mm, extensão aproximada de 8 cm, estratificação mural parcialmente preservada e aumento da vascularização mural ao Doppler, achados compatíveis c/ actividade inflamatória de doença de Crohn. Discreta hiperecogenicidade da gordura mesentérica adjacente e pequenos gânglios mesentéricos reactivos subcentimétricos. Sem colecção organizada, abscesso, tracto fistuloso, pneumoperitoneu ou líquido livre. Sem dilatação de ansas a montante ou sinais ecográficos de obstrução. Sem alterações hepatobiliares agudas.

Quadro compatível c/ exacerbação inflamatória ligeira-moderada de Crohn ileal, sem critérios clínicos, analíticos ou imagiológicos de sépsis, perfuração, abscesso ou oclusão. Hemodinamicamente estável, tolera líquidos e terapêutica oral. Caso discutido c/ Gastreenterologia; indicada corticoterapia oral transitória e reavaliação prioritária para eventual optimização de terapêutica de manutenção/biológica.

Iniciada prednisolona 40 mg PO id, após colheitas, a manter até reavaliação por Gastreenterologia nos próximos 3-5 dias; desmame posterior conforme orientação da consulta. Manter azatioprina e mesalazina nas doses habituais. Manter apixabano e bisoprolol, na ausência de hemorragia digestiva. Paracetamol SOS para dor; evitar AINEs. Hidratação oral reforçada e dieta pobre em resíduos transitória, conforme tolerância.

Explicados sinais de alarme e indicação para regressar de imediato: febre, agravamento ou generalização da dor, vômitos persistentes, distensão abdominal, incapacidade de ingerir líquidos, síncope, sangue nas fezes/melena ou taquicardia persistente. Compreende e concorda.

### **Notas de Enfermagem**

Admitida autónoma, deambulante, c/ dor abdominal referida 6/10 em FID. Canalização venosa periférica e colheitas efectuadas sem intercorrências. Administrado paracetamol 1 g PO, c/ melhoria algica para 2-3/10. Sem dejeções observadas durante permanência no SU. Reavaliação pré-alta: TA 122/74 mmHg, FC 78 bpm, T 36,6°C, SpO2 99% AA; mantém abdómen depressível, sem sinais peritoneais.

### **Diagnósticos**

(K50.8) - Doença de Crohn ileocólica, exacerbação inflamatória sem complicação

(R10.31) - Dor abdominal em fossa ilíaca direita

(R19.7) - Diarreia, não especificada

### **Medicação**

Data Início | Data Fim | Data da última toma | Designação do Fármaco

30/04/2026 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | Paracetamol 1 g PO, dose única em SU

30/04/2026 | Até reavaliação por Gastrenterologia | 30/04/2026 | Prednisolona 40 mg PO id, de manhã

30/04/2026 | Manter | 30/04/2026 | Azatioprina 100 mg PO id

30/04/2026 | Manter | 30/04/2026 | Mesalazina 1,2 g PO 12/12h

30/04/2026 | Manter | 30/04/2026 | Apixabano 5 mg PO 12/12h

### **MCDT Requisitos / Procedimentos Efectuados**

A10001 - Hemograma completo c/ fórmula leucocitária e plaquetas: leucocitose ligeira neutrofílica, Hb 11,3 g/dL, anemia normocítica ligeira.

A10012 - Bioquímica geral, função renal, ionograma, provas hepáticas, lipase e PCR: PCR 48 mg/L; função renal, ionograma, perfil hepático e lipase sem alterações relevantes.

A10146 - Calprotectina fecal: 1260 µg/g, muito aumentada, sugestiva de actividade inflamatória intestinal.

I30027 - Ecografia abdomino-pélvica: espessamento inflamatório do íleo terminal, c/ hiperémia mural ao Doppler; sem abscesso, fístula, colecção, obstrução ou líquido livre.

### **Destino do Doente**

Data: 30/04/2026

Destino: Alta para domicílio, c/ referência prioritária para consulta de Gastrenterologia em 3-5 dias.

Médico: Dr(a). Marta Lemos